

République Algérienne Démocratique et Populaire
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
Faculté de Médecine de Constantine
Département de Médecine

DIARRHÉES INFECTIEUSES

Module de Maladies Infectieuses Quatrième Année Médecine

Année 2025/2026

Dr.CHACHOU.B

INTRODUCTION:

- ❑ **Pb de santé publique** dans le monde ; surtout PED.
- ❑ Motif **fréquent** de consultation.
- ❑ Risque de cas groupé : **TIAC ; FT**
- ❑ Pandémie de cholera
- ❑ Le **plus souvent bénigne** , mais
 - **Grave** sur certains terrains âges extrêmes , immunodépression acquise ou congénitale , diabète
 - une cause importante de **mortalité** : **5 à 10 millions/an** de morts dans PED dont une majorité d'enfants
- ❑ Pb de DC **étiologique**: *Epidémiologiques + Cliniques + Paracliniques.*
- ❑ TRT essentiellement **symptomatique**.
- ❑ **Prévention**: - hygiène alimentaire, eau potable, assainissement...
 - vaccination : FT, cholera

□ DEFINITIONS:

➤ Comment définir (OMS) : **Diarrhée Aigue Infectieuse**?

- **Diarrhée** =
 - Emission de selles liquides **trop nombreuses** >3 selles/j .
 - **Trop abondantes** d'une quantité >300g/j.
- **Aigue** =
 - Début brutal .
 - L' épisode dure <14 jours en général.
- **Chronique** =
 - > 4 semaines
- **Infectieuse** =
 - Principalement **bactériennes** et **virales**.
 - Rarement **parasitaires** et **fungiques** .
- **TIAC** =
 - Toxi-infection alimentaire collective:
 - Au moins deux cas, de même origine alimentaire.

☐ Physiopathologie 1:

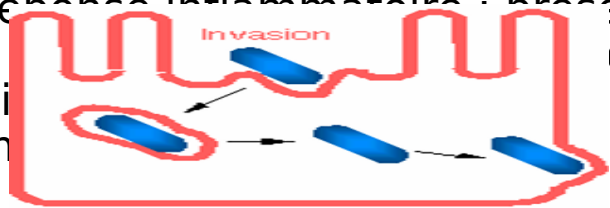
- ☐ Après **infection** du tube digestif :
 - Mode direct féco-orale (par manu portage)
 - ou indirect ++++.
- ☐ **Expression clinique** = dépend de **02 facteurs** :
 - 1- Virulence du germe **et** la dose Infectante :
inoculum (shigelles très bas)
 - 2- Moyens de défense de l'organisme :
 - la flore de barrière,
 - l'acidité gastrique,
 - la motricité intestinale,
 - le système lymphoïde
 - **Exp**: l' enfant entre 06 et 11 mois et le sujet âgé.

□ Physiopathologie 2:

➤ Mécanisme entéro-invasif:

-Type **Shigella**

- Envahissement, destruction des cellules épithéliales après multiplication
- localisation plutôt colique.
- Réponse inflammatoire : présence de de glai non



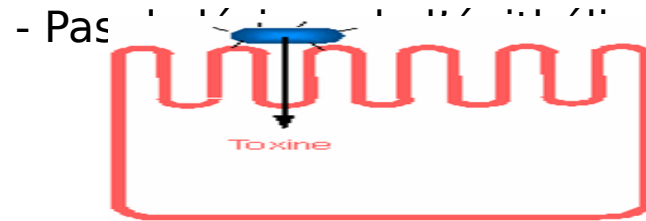
➤ Clinique: ☒ **Syndrome dysentérique**

- Douleurs abdominales intenses,

➤ Mécanisme toxinogène:

-Type **Vibrio cholerae**

- Sécrétion d'eau et d'électrolytes par les cellules épithéliales du grêle (surtout proximal)



➤ clinique: ☒ **Syndrome cholérique**

- Diarrhée aqueuse, selles liquides profuses
« eau de riz ».
- Vomissements et douleurs abdominales
- Souvent associées à des signes de déshydratation (gravité / terrain +++).
- PAS de fièvre.

☐ Physiopathologie 3:

☐ Mécanisme mixte : Entéro-invasif +Toxinogène

-Type **Salmonella**.

- Envahissement et traversée de l'entérocyte sans destruction.
- Multiplication de la bactérie dans la sous-muqueuse (macrophages).
- Atteinte de l'intestin grêle Risque de diffusion systémique :

Exp: Salmonella typhi (immunodéprimés, drépanocytaires).

➤ **Clinique:** ☒ **Syndrome gastro- entéritique .**

- Signe «d'invasion ».
- Fièvre.
- Douleurs abdominales.

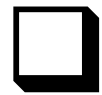
➤ On distingue deux formes **anato-mo-cliniques**:

❑ **diarrhées invasives :**

- Mécanisme direct: **shigelles** , **EIEC** ou
- Indirect par toxines **EHEC** , **clostridium.d**
 - Ulcération ,œdème et hémorragies
 - Une nécrose cellulaire, des abcès de paroi, diarrhée sanglante, fausses membranes(syndrome dysentérique).
- D'où le syndrome fébrile, leucocytes et sang dans les selles.
- Risque de passage systémique : (S. mineure , typhie).

❑ **Les diarrhées dites hydriques:**

- De type sécrétoire , toxinogène.
- Action sur la partie proximale de l'intestin grêle.
- EXP:-v cholérique, ETEC ,
 - staph aureus , bacillus céréus.



Conduite pratique:

- **Identifier** une diarrhée (**OMS**):
- Identifier les situations **d'urgence**.
- **Mise** en condition .
- Transfert en **U.S.F** ou **NON**.
- Diagnostique **étiologique**.
- Traitement : - spécifique.
- préventif.

❑ Identifier les situations d'urgence:

1- Déshydration: extracellulaire +/- intracellulaire

- Hypo perfusion des organes :
 - Cerveau: troubles de conscience.
 - Rein: oligo-anurie et IRA.
- signes de compensation : tachy cardie , polypnée,
- signes de décompensation: collapsus et choc hypo volemique.

2- Syndrome pseudo-occlusif:

- Une colite grave.
- Hypokaliémie.
- Complication iatrogène : prise d'inhibiteurs de la motricité intestinale
comme le lopéramide..

3- Sepsis grave et formes bactériémique:

- Terrain particuliers: immunodéprimés..
- Sepsis = SRIS + infection.
- Hémocultures + coprocultures.
- ATB (C3G IV ou fluor quinolones)
- Rééquilibration hydro- électrolytique

4 -Diarrhée fébrile au retour d'un voyage récent en pays d'endémie palustre:

- Paludisme (Frottis sanguin et goutte épaisse).
- TRT.sps.

❑ Mise en condition:

- Si présence de **signes de gravites** ---->Transfert en **U.S.F**.

→ la loi des 4 tuyaux:

- 1-** Abord veineux périphérique ou centrale de bonne qualité.
- 2-** Libération des les vois aériennes :
 - lunette d'o₂
 - Aspiration bronchique
- 3-** Sonde naso gastrique.
- 4-** Sondage urinaire pour quantifier la diurèse.

❑ Eliminer les causes non infectieuses :

➤ **Diagnostic. Différentiel:**

- **Causes fonctionnelles:** colopathie spasmodique
- **Causes médicamenteuses:** anti-inflammatoires...
- **Causes toxiques:** champignons , végétaux vénéneux , poissons....
- **Entérocolopathies inflammatoires :** rectocolite hémorragique , maladie de Crohn....
- **Syndromes de malabsorption:** malnutrition
- **Causes tumorales:** KC colon , tumeur du grêle, polypose intestinale..
- **Causes endocriniennes:** diabète , tumeurs carcinomateuses.....

□ Dg. Positif:

➤ Arguments anamnestiques: +++

- Aspect des selles.
- Nombre de selles et abondance.
- Date et l'heure de début .
- Lien éventuel avec un repas suspect : viandes peu cuites , laitage non pasteurisé , œufs , pâtisserie , glaces...
- Survenue isolée ou collective .
- Rechercher les signes associés:
 - vomissements: phénomène toxique (risque de déshydratation)
 - douleur abdominale
 - épreintes ,ténésmes
 - fièvre: volontiers diarrhées invasives (DHA)
- Environnement et terrain de survenue:
 - Séjour en zone d'endémie, voyage
 - Prise d'antibiotiques
 - Déficit immunitaire: - Déficit en IgA : Lamblia /Salmonelles
 - Transplanté : CMV
 - Sida : Cryptosporidies
 - Drépanocytaire : Salmonelles

➤ **Trois** aspects cliniques à distinguer :

☐ **Diarrhées cholériques:**

- Diarrhées aqueuse .
- Selles bondantes, fréquentes .
- Parfois vomissements .
- Peu ou pas de douleurs abdominales. - pas de fièvre .
- DHA rapide.

☐ **Diarrhées**

dysentériques: -

- Selles nombreuses , afécales glaireuses , parfois sanglantes.
- Douleurs abdominales ou coliques en cadre +épreintes + ténésme.
- Fièvre

☐ **Syndrome gastro-entérique:**

- Selles liquides
- Douleurs abdominales au premier plan.
- Vomissements ,
- Fièvre .

□ Éléments de confirmation:

➤ **Diagnostic bactériologique des diarrhées infectieuses aiguës:**

□ **Examens des selles:**

- Recherche des **leucocytes** altérés dans les selles.
- La **coproculture**:
 - A partir des selles ou écouvillonnage rectal
 - Acheminement rapide au laboratoire
 - Les micro-organismes recherchés : salmonelles, Shigelles .
Campylobacter jejuni , Yersinia entérolytica ...
 - Selon les circonstances , on recherchera :
 - Vibrio cholerae lors d'un séjour en zone d'endémie.
 - C. difficile et sa toxine devant une diarrhée survenant sous ATB.
- Recherche **d'antigènes** bactériens *C. Difficile*.
- **Sérologie** inutiles dans le diagnostic des diarrhées aiguës.

➤ ***Diagnostic virologique des diarrhées infectieuses aiguës:***

- **Culture cellulaire** : n'est pas une méthode utilisable en routine.
- **Microscopie électronique** : - matériel coûteux et reste l'apanage de centres spécialisés.
- **Méthodes immunologiques** : la recherche directe d'**AG** viraux dans les selles.
- **Biologie moléculaire** : ne relève pas encore de la pratique courante

❑ **Diagnostic parasitologique des diarrhées inf. aiguës :**

- Examen des selles:

- l'examen direct des selles à l'état frais, et coloration lors de la recherche de formes kystiques.
- Examen négatif = caractère intermittent des éliminations parasitaires et faire renouveler l'examen.

- Examens sérologiques :

- les trichinoses et les bilharzioses.

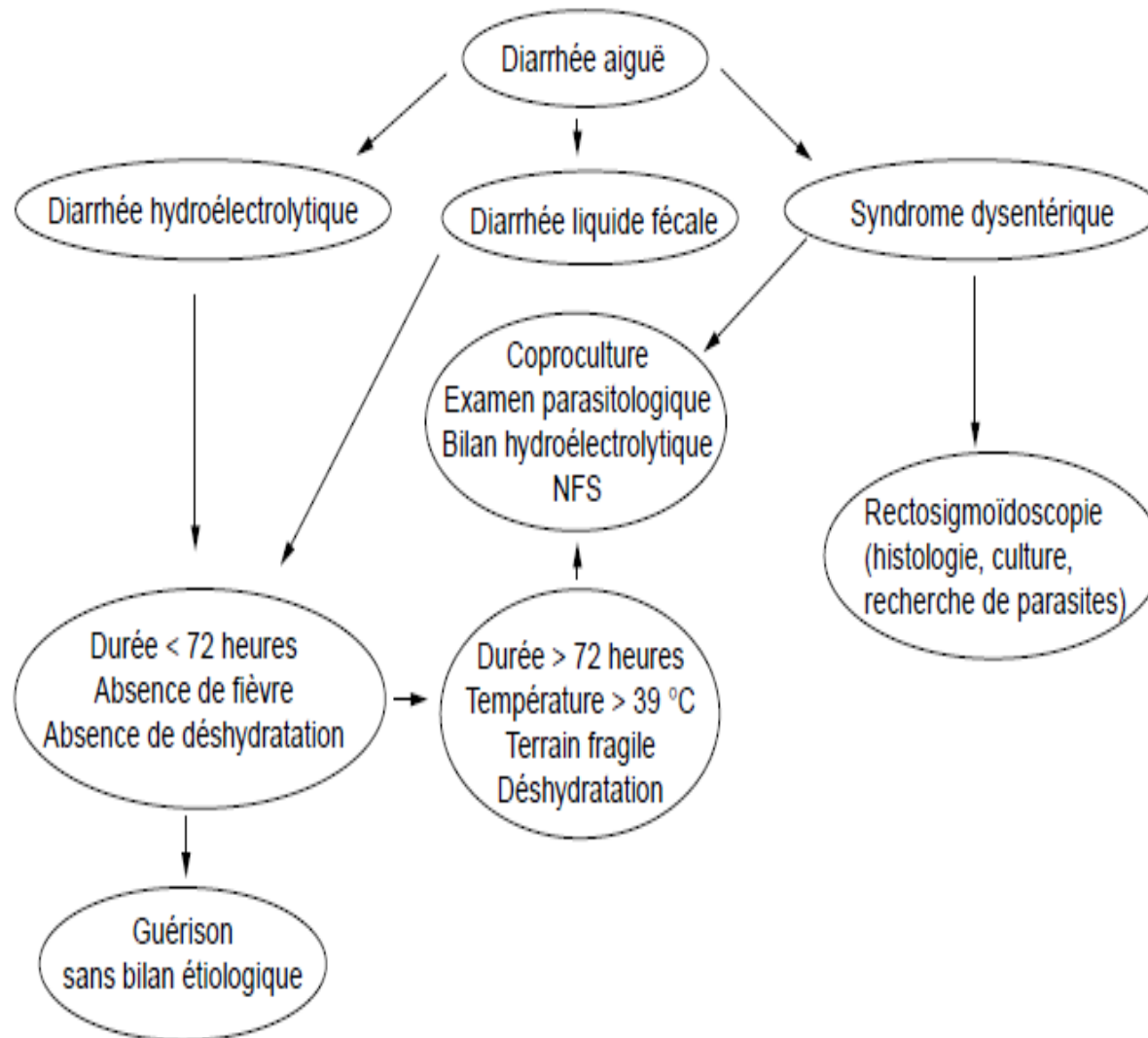
- Tests immunologiques :

- immunofluorescence, méthodes immuno enzymatiques.
- La recherche des cryptosporidies et de *Giardia lamblia*.



Prise en charge:

1 *Prise en charge clinique d'une diarrhée aiguë.*
NFS : numération formule sanguine.



➤ Diagnostique étiologique:

Tableau V. – Caractéristiques des principales diarrhées aiguës bactériennes et virales [12, 42, 43].

Diarrhées bactériennes aiguës de type hydroélectrolytique						
Germes	Distribution géographique	Transmission	Réservoir	Délai d'incubation	Symptomatologie	Complications
<i>Aeromonas</i> ⁽¹⁾	Cosmopolite (Extrême-Orient)	Eaux (coquillages, poissons) Contact direct	Poissons, homme	Quelques heures à quelques jours	Fièvre, douleurs abdominales, diarrhées	Septicémie, mégacolon
<i>Bacillus cereus</i> ⁽²⁾	Cosmopolite	Cuisine chinoise (riz frit) Bouillons (viandes, légumes)	-	2 à 3 heures 8 à 16 heures	Nausées, vomissements Diarrhées, douleurs abdominales	
<i>Clostridium perfringens</i> ⁽²⁾ • type A • type C	Cosmopolite	Viande, abats, plats cuisinés Porc mal cuit	Sol Sol	8 à 22 heures 24 heures	Diarrhées, douleurs abdominales, fièvre et vomissements rares Douleurs abdominales ++ et fièvre	Rare 40 % de décès ++
<i>Escherichia coli</i> • Entérotoxigène • Entéropathogène	Cosmopolite Cosmopolite	Salades, eaux Aliments, eaux	Homme, animaux Homme, animaux	1 à 2 jours 1 à 2 jours	Douleurs abdominales, fièvre (30 %) Diarrhées, douleurs abdominales, vomissements	 Fièvre prolongée
<i>Staphylococcus aureus</i> ⁽²⁾	Cosmopolite	Jambon, charcuterie, pâtisseries, laitages	Homme	2 à 6 heures	Vomissements, douleurs abdominales, diarrhées	
<i>Vibrio cholerae</i> ⁽²⁾	Asie (delta du Gange)	Eaux, aliments, porcs sains	Homme	1 à 3 jours	Vomissements, douleurs abdominales, diarrhées	<i>Vibrio cholerae</i> non O : 1 Diarrhées sanglantes (25 %)
<i>Vibrio parahaemolyticus</i> ^(1, 2)	Japon, États-Unis, tiers-monde	Fruits de mer	Poissons	2 à 48 heures	Diarrhées, fièvre, vomissements, douleurs abdominales	

Diarrhées bactériennes aiguës avec atteinte iléocolique droite et/ou rectocolique

Salmonelles non typhiques ⁽²⁾	Pays industrialisés	Volailles, œufs, produits laitiers	Animaux domestiques	8 à 48 heures	1 à 8 jours (voire plus)	Septicémie, mégacôlon
Shigelles	Pays tropicaux, zones tempérées	Aliments, contacts directs	Homme	1 à 3 jours	7 jours	Syndrome hémolytique et urémique, hémorragies intestinales et perforations, mégacôlon, rechutes
<i>Yersinia enterocolitica</i>	Europe du Nord, États-Unis, Australie	Lait, glace, porc	Animaux	5 à 10 jours	Quelques jours à 3 semaines	Manifestations extradi-gestives, formes prolongées
<i>Campylobacter jejuni</i>	Europe, États-Unis, Australie, Japon	Volailles, lait non pasteurisé	Animaux domestiques et sauvages	1 à 10 jours	7 jours	Mégacôlon, colite pseudomembraneuse, adénite mésentérique, polyradiculonévrite, méningite
<i>Escherichia coli</i>						
- entérohémorragique	Cosmopolite	V viande mal cuite, lait, eaux	Homme, animaux	3 à 4 jours	7 à 9 jours	Syndrome hémolytique et urémique, colite hémorragique
- entéro-invasif		Fromages	Homme, animaux	1 à 3 jours	7 jours	Diagnostic difficile avec <i>Shigella</i> sp.

Diarrhées aiguës virales

Type de virus	Répartition	Incubation	Tableau clinique	Durée
Rotavirus (virus à ARN)	Première cause de diarrhée aiguë virale chez l'enfant. Adultes moins souvent atteints (transmission de l'enfant à l'entourage adulte). Diarrhées du voyageur. Contamination possible par eau. Transmission nosocomiale possible. Expression hivernale sous les pays tempérés	1 à 3 jours	Diarrhée profuse, vomissements, fièvre fréquente, symptomatologie respiratoire inconstante	4 à 7 jours
Virus Norwalk, Norwalk-like et calicivirus (virus à ARN)	Surtout les adultes et les grands enfants, épidémies fréquentes dans les collectivités, contamination alimentaire possible par les fruits de mer	1 à 3 jours	Diarrhée hydrique, vomissements parfois au premier plan, fièvre (ou syndrome pseudogrippal)	1 à 2 jours
Adénovirus entériques (virus à ADN)	Distribution mondiale, deuxième cause de diarrhée aiguë virale chez l'enfant, atteinte plus rare chez l'adulte	8 à 10 jours	Diarrhées, vomissements, fièvre peu élevée durant 2 à 3 jours, possibles signes respiratoires	5 jours à plus de 2 semaines
Astrovirus (virus à ARN)	Atteinte surtout des nourrissons et des enfants jusqu'à l'âge de 7 ans, petites épidémies dans les collectivités de personnes âgées	1 à 4 jours	Diarrhées surtout, vomissements et fièvre inconstants	2 à 4 jours

ADN : acide désoxyribonucléique ; ARN : acide ribonucléique.

⁽¹⁾ Principales bactéries responsables de syndrome dysentérique.

⁽²⁾ Bactéries principalement responsables de toxi-infection alimentaire.

❑ Traitement :

❑ **Trois objectifs:**

- Corriger ou prévenir la **déshydratation**.
- Réduire **l'intensité** et **la durée** de la diarrhée.
- Lutter contre **l'infection** digestive.

➤ 1- MESURES HYGIÉNODIÉTÉTIQUES:

❑ **Réhydratation :**

- Constitue le principal traitement des diarrhées aiguës, srt hydroélectrolytiques.
- Correction de la déshydratation: par voie orale chaque fois que c'est possible
- Par voie veineuse si :
 - DHA sup ou égale à 10%
 - vomissements
 - signes de collapsus
 - troubles de la conscience
- Solutés de RHD : - 100 à 120 ml/kg les 06 premières heures,
 - puis fonction de l'état du patient et des pertes.

❑ **Régime alimentaire :**

- Les régimes classiquement recommandés :
 - riz, bananes, jus de pomme, carottes, pâtes.

❑ 2-TRAITEMENTS MÉDICAUX :

❑ **Antibiotiques :**

- L'évolution des diarrhées aiguës étant le plus souvent favorable, leur prescription systématique **n'est pas justifiée**.
- Ils sont donc indiqués, après prélèvements, en cas :
 - De **diarrhées invasives** , avec symptômes sévères.
 - De **terrain fragile** .
 - De persistance (ou d'aggravation) de la diarrhée après **3j** d'évolution spontanée.
 - Durée limitée: 03 à 07jours / 14 pour *Campylobacter*.
- les **fluoroquinolones** en traitement de première intention chez l'adulte.
- L'**azithromycine** s'avère efficace sur les diarrhées à *Campylobacter* ou à *shigelles*.
- Le **cotrimoxazole** est l'antibiotique utilisé habituellement chez l'enfant.
- l'**ampicilline** peut être utilisée sans risque chez la femme enceinte.

❑ Antibiothérapie des diarrhées de cause bactérienne:

Germe	ATB 1^{ère} intention	durée	Alternative
salmonella	fluoroquinolone	05 jours	Bactrim , C3G
Shigella	fluoroquinolone	05 jours	Bactrim, C3G,aminopenicilline
Campylobacter	Macrolides	14 jours	Fluoroquinolones
Y.entérocolitica	doxycycline	10 jours	Bactrim, fluoroquinolones
Clostridium difficile	metronidazole	10 jours	vancomycine
Vibrio cholerae	doxycycline	03 jours	bactrim

❑ **Antidiarrhéiques:** Il existe deux grandes classes :

1- Lopéramide:

- Il possède à la fois un effet anti sécrétoire et un effet antipéristaltique .
- contre indiqué devant tout syndrome dysentérique, de météorisme abdominal important
- risque de mégacôlon toxique + diffusion bactérienne systémique .

2- Antidiarrhéiques anti sécrétoires purs :

- En pratique très efficaces et n'exposent pas au risque de mégacôlon toxique .

❑ **Antiseptiques :**

- Action bactériostatique sur les BGP (staphylocoques et streptocoques) et surtout sur les BGN.

❑ **Pansements adsorbants:**

- Les argiles tels que la smectite et dérivés, entraînent chez l'enfant une amélioration de la consistance des selles.

❑ Traitement préventif :

- Repose essentiellement sur **l'hygiène hydrique et alimentaire.**
- La propreté des **mains.**
- Contrôle de **l'industrie alimentaire.**
- Dépistage et traitement des **porteurs de germes.**
- Rigueur dans ces mesures en cas de voyage en milieu **tropical .**
- Vaccination bact ou viraux : efficacité **modérée.**

❏ **Conclusion:**

- **Les diarrhées infectieuses aiguës exigent une prise en charge *bien codifiée*.**
- **Le *bon sens clinique* permet de rechercher les signes de gravité et de compenser une éventuelle déshydratation.**
- **La connaissance du caractère *invasif* de la diarrhée ou d'un *terrain fragile* grâce à *l'interrogatoire* induit la prescription d'examens par acliniques pour mettre en évidence *l'agent pathogène* responsable et appliquer éventuellement un traitement *curatif* adapté.**